

Protocolo de Fotografía Clínica Dental

Documentación y Registro en Estomatología | Catedrático: Dr. Miguel Alvarado

La fotografía clínica es una herramienta diagnóstica, legal y de comunicación indispensable en la práctica odontológica moderna. No solo permite el análisis detallado de los tejidos duros y blandos en ausencia del paciente, sino que es el estándar de oro para la presentación de casos, planificación de tratamientos (como la ortodoncia y ortopedia maxilar) y seguimiento longitudinal.

1. Conceptos Básicos de Fotografía (Triángulo de Exposición)

Para lograr fotografías clínicas nítidas, bien iluminadas y estandarizadas, es fundamental dominar los tres pilares de la exposición fotográfica:

- **Apertura del Diafragma (f-stop):** Controla la profundidad de campo (qué tanto de la imagen está enfocado). Se utilizan aperturas cerradas (f/22 a f/32) para tomas intraorales y medias (f/8 a f/11) para extraorales.
- **Velocidad de Obturación (Shutter Speed):** Se recomienda de 1/125 a 1/200 para evitar trepidación y sincronizar con el flash.
- **Sensibilidad ISO:** Debe mantenerse lo más bajo posible (ISO 100 o 200) para evitar "ruido" visual.

2. Tipos de Fotografía en Odontología

- **Registro de Caso Clínico (Estandarizado):** Imágenes objetivas con encuadres y proporciones fijas (1:3 sonrisas, 1:10 rostro). Su objetivo es puramente diagnóstico (cefalométrico, facial, dental) y de protección médico-legal. Muestran la realidad clínica sin buscar el factor artístico.
- **Fotografía Macro / Estética / Artística:** Se centra en el detalle extremo (1:1). Usa contrastadores y luces direccionales para resaltar texturas, mamelones y translucidez, enfocada a laboratorios o marketing.

3. Secuencia Fotográfica Principal: Análisis Detallado

Para la presentación de casos clínicos estructurados, se requiere una serie de fotografías donde cada toma tiene un "qué", un "para qué" y criterios estrictos de encuadre.

A. Fotografías Extraorales

Objetivo Principal (Para qué): Evaluar la simetría facial, proporciones de los tercios faciales, biotipo facial, soporte labial y perfil del paciente. Es la base del diagnóstico ortodóntico y ortopédico integral.

Posición del Paciente y Entorno:

- El paciente debe estar de pie o sentado con postura natural, mirando a un punto fijo al horizonte.
- El **Plano de Frankfort** (tragus-borde infraorbitario) debe ser estrictamente paralelo al piso.
- Rostro despejado: cabello recogido detrás de las orejas, frente descubierta y sin lentes ni distractores.
- **Evitar sombras:** Separar al paciente al menos 50 cm del fondo (blanco, gris neutro o negro). Utilizar un segundo flash esclavo apuntando al fondo o flashes gemelos simétricos para evitar sombras proyectadas que distorsionen el contorno del rostro.

1. Frontal en Reposo

- **Enfoque:** Directo a los ojos del paciente.
- **Qué se debe ver:** Rostro completo desde el nacimiento del cabello hasta la base del cuello. Orejas simétricamente visibles. Labios en posición de descanso sin forzar el sellado.
- **Para qué:** Valorar asimetrías transversales, competencia labial, hipertonía del músculo mentoniano y la exposición en milímetros de los incisivos superiores en reposo.

2. Frontal en Sonrisa

- **Enfoque:** Directo a los ojos del paciente.
- **Qué se debe ver:** Expresión natural de alegría (sonrisa social plena). Los márgenes gingivales, espacio negativo y curva de la sonrisa.
- **Para qué:** Analizar la línea de sonrisa (alta, media, baja), el corredor bucal, la consonancia del arco dentario con el labio inferior y la desviación de las líneas medias dentales respecto a la facial.

3. Perfil (Derecho) en Reposo

- **Enfoque:** A la zona del pómulo / ojo del lado derecho.
- **Qué se debe ver:** Perfil estricto (no se deben ver las pestañas del ojo izquierdo). Comprende desde la glabella hasta el cartílago tiroides en el cuello.
- **Para qué:** Evaluar la convexidad facial, el ángulo nasolabial, la proyección del mentón, el perfil labial (competencia y límite en la Línea Estética de Ricketts) y el ángulo submentoniano.

B. Fotografías Intraorales

Objetivo Principal (Para qué): Registro de la oclusión estática (Máxima Intercuspidación - MIC), estado periodontal, clasificación de Angle, sobremordidas, forma de las arcadas y malposiciones dentarias.

Condiciones Clínicas Obligatorias:

Los dientes deben estar limpios. Es vital usar la jeringa triple para secar las superficies dentales y evitar reflejos especulares de saliva. Los dedos o guantes del operador nunca deben aparecer en la fotografía terminada.

1. Frontal en Oclusión (MIC)

- **Enfoque y Profundidad:** Enfoque puntual en los incisivos laterales o caninos (f/22 o f/32) para asegurar nitidez desde la línea media hasta los molares.
- **Qué se debe ver:** Desde los incisivos centrales hasta los primeros molares. El plano oclusal debe estar perfectamente horizontal. Los retractores en "C" deben despejar completamente las comisuras y frenillos laterales.
- **Para qué:** Evaluar el overbite (sobremordida vertical), coincidencia de líneas medias dentales, nivelación de márgenes gingivales, biotipo periodontal y presencia de apiñamiento anterior.

2. Lateral Derecha e Izquierda (MIC)

- **Enfoque y Profundidad:** Enfoque sobre la cúspide del canino o en el primer premolar.
- **Qué se debe ver:** El plano oclusal estricto y horizontal. Debe visualizarse desde el incisivo lateral/central hasta el primer o segundo molar. El retractor en "V" del lado a fotografiar debe traccionar fuertemente la comisura hacia atrás; el retractor del lado opuesto solo se sostiene sin ejercer tensión.
- **Para qué:** Determinar con exactitud la Relación Molar y Canina de Angle, evaluar el overjet (resalte), la Curva de Spee y la calidad de la intercuspidación lateral.

3. Oclusal Superior e Inferior

- **Enfoque y Profundidad:** Enfoque central en la zona de los premolares, usando el espejo fotográfico oclusal.
- **Qué se debe ver:** La arcada completa en forma de "U" o "V", desde los incisivos centrales hasta las caras oclusales de los últimos molares erupcionados. El lente de la cámara debe estar perpendicular al reflejo del espejo. **Criterios de rechazo:** cortes en los bordes incisales, vaho (espejo empañado, se evita calentando el espejo o echando aire con la jeringa) o la aparición del labio/nariz del paciente.
- **Para qué:** Analizar la forma de la arcada, constricción maxilar/mandibular, simetría transversal, giroversiones, apiñamiento o espaciamientos, y morfología de las caras oclusales.